

## X線撮影時の放射線防護策について

日常のX線撮影において、患者を支えたり、付き添ったりしながら撮影を実施することがあります。患者にとっては病気を知る上で、必要な検査であり、有益な被ばくといえますが、介助者にとっては、何のメリットもない被ばくです。人体に影響のでない極々微小な被ばくであっても、これは避けなければいけません。そのためには、患者のそばで介助を行う者は、防護プロテクターを着用する必要があります。

### ◎Point

- ① 人体に影響のでない極々微小な被ばくであっても、介助者にとっては、何のメリットもない被ばく。これは避けるべき被ばくである。
- ② 患者のそばで介助を行う者は、防護プロテクターを着用する。



## 一般病棟や手術室でのポータブル撮影

X線撮影の線量は、照射中心から2m離れた場所では、腹部撮影の場合は、0.5 $\mu$ SV程度、胸部撮影の場合は、0.1 $\mu$ SV程度になり、離れば離れるほど線量は減衰していきます。

自然放射線源の一つである宇宙線から、一日に受ける線量が1 $\mu$ SVであると考えれば、この程度の線量は特に問題にする量ではないと考えられています。

医療法による病室の床面積の規則から考えると、大部屋で臥床している患者間の距離は1.5m以上あると考えられるので、撮影の際、隣の患者を退出させる必要はありません。また医療従事者も、2m以上離れるようにすれば安心であると考えられます。

但し、頸椎や腰椎などの撮影で、横向きで撮影する場合は、照射方向にいる患者は、退出してもらいます。

### ◎Point

- ① 胸部・腹部X線ポータブル撮影時、ベッド上で臥せている限り、同室患者を退出させる必要はない。
- ② 頸椎、腰椎など横向きなどで撮影するときは、照射方向（線束方向）にいる患者は退出してもらおう。スタッフも照射方向には行かない。
- ③ 技師、看護師、医師、見舞い・付き添い者など、2m以上離れた位置であれば退出の必要はない。
- ④ 「走って離れる」「あわてる」など患者の不安につながる行動はとらない。

●放射線防護の観点で言えば撮影患者から2mの距離をとっていれば被ばくの問題がないといえます。しかし、いかに少ないとはいえ被ばく線量はゼロではありません。可能であれば、退室できる同室患者や面会者には退室を促します。

